

* Poussée Hypertensive :

PAS ≥ 180 mmHg et/ou PAD ≥ 110 mmHg
Classification : But = 140/90 mmHg

* HTA sévère : $\uparrow$ TA sans souffrance viscérale
 $\Rightarrow$ Trt Ambulatoire

* Urgence Hypertensive : $\uparrow$ TA avec souffrance
 $\Rightarrow$ (H)

- Rassurer le patient
- Prise de TA
- O₂ thérapie 3-4 l/min
- Voie d'abord
- Rechercher l'étiologie si : stress...

+ 0.1 Amp pimpe ran en IM 30 min
si : TA normale $\Rightarrow$ Bilan HTA.

* Bilan : FNS / glycémie à jeun / Urée / Créat
CT / HDL-c / LDL-c / TG / Urée / CU

ionogramme sanguin

* Si : TA après 30 min pas d' (A) :

$\Rightarrow$ Captopril 1 cp 25 0.1 cp en ~~sublingual~~
après 0.1 h pas d' (A) : en per os !
 $\Rightarrow$ 2ème cp

- * R après 01h pas d'①A ⇒ 2^{ème} cp
- après 01h pas d'①A : (cp inefficace)
- ⇒ Loxen inj 01cc diluée en 3cc SG 5% IV0
- après 30min pas d'①A : 02cc puis 03 ... 10cc

Ordonnance :

11 - Amlor 5mg _____ 01 hte

01cp 1j à heure fixe

+ Bilan d'HTA + Régime 1/2 sale

⇒ Avis Cardio!

+ Profil TA 3x1j pdt une semaine

* Clinique :

⇒ Céphalée / vertiges / Acouphènes / épistaxis

* éliminer une urgence hypertensive :

* AVC ⇒ signes neuro de localisation

* Dissection Aortique ⇒ Douleur rétro

sternale en coup de poignard migratrice irradiant vers le dos, souffle Aortique

* OAP ⇒ dyspnée + ~~rales~~ crépitaux

* IDM ⇒ douleur thorax constrictrice irradiant vers l'épaule gauche + signes ECG

* Rétinopathies hypertensives, pré éclampsie

* AVC *

* clinique: Troubles neurologiques

⇒ Aphasie ou Dysarthrie, Céphalée, Flou visuel
Paralysie faciale centrale ou périphérique
Déficit moteur: Hémiparésie ou Hémiplogie
Dg ≠ = perte des urines ou morsure de la langue ⇒ crise épileptique

Note: TA > 18/10 ne pas ↓ TA avant TDM.
sauf si TA = 220/120 on ↓

. CAT: * 2^e thérape / Vire d'abord / TA / T°
Dextro. + ECG pour éliminer IDM

⇒ Evacuation pour faire une TDM Cérébrale

* Scanner:

20% Hyperdensité: AVC hémorragique
80% Hypodensité: AVC ischémique
→ Evaluation Neurochir
→ (+) ou (-) 24 à 48h.

Scanner normal ⇒ suspicion d'AVC ischémique
à refaire 48-72h après.

⇒ Mannitol 100cc / 8h

⇒ SGI est CI ⇒ risque d'œdème cérébral

- * Metelas antireuxures
- * O₂ thérapie 0.3 l/min sauf si SaO₂ est normale
- * Réhydratation SSI 18 h 0.1 glucan
- si $\uparrow$ $\Rightarrow$ 0.1 glucan de perfalgan 108 h
- si $\uparrow$ glycémie
- ④ 2g $\Rightarrow$ insulinothérapie
- 10 UI IO en sous cutané / h
- ④ 24 h $\rightarrow$ 48 h pas d'alimentation orale
- après 2 j alimentation orale si pas
- $\Rightarrow$ sonde gastrique + vésiculaire

Ordonnance :

Somazina Amp 500 mg en IVL
 250 cc SSI 140 gtt / min
 0.1 Amp / 24 h

Bilan :

- $\Rightarrow$ FNS / glycémie à jeun / urée / créat / CT / TG
- ionogramme sanguin
- * si $\downarrow$ Hypo Na⁺ $\Rightarrow$ NaCl 3g / j = 1g / flacon
- Hypo K⁺ $\Rightarrow$ KCl 2g

* Si = Risque d'infection nosocomiale "Préventif"
Cefotaxime $\Rightarrow$ Claforan 1g/12h 2x1j
ou Augmentin 1g/12h.

* Si = TA > 230/120.

$\Rightarrow$ 01 cc Loxen dilué SG 5%

* ECG = TDR $\Rightarrow$ Avis Cardio / Med interne

• 03 Lettres =

* Consultation Cardio!

* Consultation Neuro!

* Consultation Kinésithérapie!

01 mois $\Rightarrow$ Mvt passifs

01 mois $\Rightarrow$ Mvt Actifs

* QAP :

* Clinique : Dyspnée, détresse resp, Cyanose, difficulté de parler, Hypotension $++$, Ra $++$ crépitants $++$, Toux sèche, glaire blanchâtre, sueurs, fièvre presque crise d'asthme mais pas d'HTA d'asthme même en présence de râles sibilants $\oplus$ 50 ans HTA / Cardiopath

8-10l
* O₂ thérapie / Dextro / TA / T° / Voie d'abord
 $\Rightarrow$ position $1/2$ assise, pieds pendante.

* δ : TA > 110 mmHg
 $\Rightarrow$ Lasix 40 mg en IVD chaque 20 min

* Bilan : FVS / glycémie / Urée / Créat si IR $\nearrow$
Lasix 120 mg / ionogramme / CRP

* TLT de force $\Rightarrow$ Confirme le dg

* ECG $\Rightarrow$ IDM

• 250 mg Aspirine
 • 0.1cp plavix
 • 0.14 Tennox en SC

} Thrombolyse

20 - 30 min $\delta = TA$ est $T_j > 110 \text{ mmHg}$
 $\Rightarrow$ Lasix 40 mg en IVD
ou Léntrol 1 mg en IVD
ou Risoran 2 mg en IVD

* $\delta =$ Non reprise $\Rightarrow$ Avis δ !

$TA < 110 \text{ mmHg} :$

$\Rightarrow$ O₂ théra δ pré os-10l.
Voie d'abord

SG 5%

$\Rightarrow$ Avis δ : Dobutrex 5 $\mu\text{g/kg/min}$



* DOM :

* Clinique : Douleur constrictrice / Brûlure irradiée vers la mâchoire inférieure au poignet / épaule gauche pâle / cyanosé / sueurs !
⇒ O₂ / Thérapie / TA / dextro / voie d'abord

⇒ H L₂ Si SaO₂ < 90%

⇒ Bilan : FNS / TP / glycémie / Urée / Créat / ionog

⇒ ECG : 5 min 9e fois 10 min.

Sur décalage > 2 mm d'au - 2 D
ds 2 ECG de 20 min d'intervalle

⇒ Soulager la douleur : 01 flacon de parafalgan
voir un dérivé morphinique si la douleur est intense

⇒ Chlorhydrate de morphine 5mg inj
1/2 Amp en s/c ou IV.

Ordonnance :

- 1) - Aspirine 300 ou 250mg en IV puis
+ 1 sac 100mg/lj
 - 2) - Plavix 75mg (ou ip) en 1 seule prise puis
 - 3) - Xovenox 4000 UI ——— 1 c p lj
100 UI / Kg en s/c 2x 1j
- 0,3 CC en IV D (8) ⇒ Evacuation en 2 Carctio!

* Loma :

- ⇒ Position latérale de sécurité "PLS"
- ⇒ 2^e thérape / Dextro / TA / T° / Vœ d'abord perfusion SST
- ⇒ Bilan : FNS / glycémie / Urée / Créat / CPK ASAT / ALAT / ionogramme sanguin
- ⇒ ECG

Si : Trauma
 Crâne
 Si = pas Trauma

signes de focalité ⇒ Avis Neuro!
pas signes de focalité ⇒ Scanner

- CO ⇒ O₂ 8l / min
- médicaments ⇒ O₂ + 100mg HHC en IV
- Hypoglycémie ⇒ 50cc SG 30% puis perfusion 01 flacon SG 10%
01 flacon SG 5%

01 flacon 18h

resuscitation de conscience ⇒ Alimentation (glucide / lipide) pour éviter le Rckn.

* coma hypoglycémiques

- * clinique : Trouble de conscience ou neuro
⇒ glycémie veineuse $< 0.5 \text{ g/l}$ ou $< 2.8 \text{ mmol/l}$
(asthénie, tremblet, sueurs, faim,
Tachycardie, céphalée, vertiges, acouphènes
Trouble visuels, déficit moteur)

⇒ O₂ thérape IVe d'abord | Dextro | TA

- * Si = patient conscient

- Administration en urgence de boissons sucrée

- * Si = patient inconscient

⇒ 50cc SG 30% en IVD

⇒ 50cc SG 10% en 1h

Relais ⇒ 01 flacon SG 5% / 8h

chez le diabétique risque de rechute
ou si voie d'abord difficile (coma agité)

⇒ 1-2mg 01 Amp de glucagone en IVD ou SC
20 min Si = glycémie T_j ↓ 2^{ème} Amp

Glucagon CI : Alcoolisme / S / sulfamide hypogly

- * Si = insuffisance ^{sur} rénale aigüe : ISA

⇒ 200 mg HHC en IVD

* Hyperglycémie Sans Cétose :

- Sujet diabétique : mauvaise prise de Trt en infect
- Sujet non diabétique : Vertiges, adhérence, fécès

PDF : * Dextro $> 2.5 \text{ g/l}$ * Labstix : CC (-)

$\Rightarrow$ Insuline IO : 10 UI en SC / h.

+ Réhydratation : Boire 1.5 l d'eau + perfusion SSI ... 6 flacons (1.5 l d's 2h)

$\Rightarrow$ TLT : rechercher infections pulmonaires

$\Rightarrow$ Labstix : infection urinaire $\Rightarrow$ ECBU.

$\Rightarrow$ ECG : rechercher Hypok⁺ si (+) à corriger avant l'insulinothérapie.

$\Rightarrow$ Surveillance de glycémie capillaire / 30 min

si : FDR + Découverte gly $\uparrow \Rightarrow$ (H)

si : CC (+) + gly $\uparrow \Rightarrow$ (H)

* Après 01h :

! si : CC (-) + gly $< 2 \text{ g/l}$ $\Rightarrow$ Libérer avec un Trt $\leftarrow$ biologique si infect

si : CC (-) + gly $> 2 \text{ g/l}$ $\Rightarrow$ Continuer même schéma d'insulinothérapie jusqu'à l'obtention de l'objectif de Trt

- Si CC (+) + gly $> 2 \text{ g/l}$ $\Rightarrow$ Continuer même schéma sans insuline à la seringue élective
- Si Patient instable appel Pa Réa !
 $\Rightarrow$ Avis Réa !
- $\Rightarrow$ Ne libérer jamais le patient sans $(-)$ du CC.

PDF: Ucé / Créat / ionogr — e .

ECG = IDM / signes HyperK⁺ (onde T pointue /
QRS élargie / PR > 0,2s chaque 2h
Si: K > 6,5 mm $\Rightarrow$ Avis Réa!

- 2-6h: SG 5% (2L) si gly < 3g $\rightarrow$ 1,5g
+ 2g NaCl (0,5 ds chaque flacon)

Si: ionogramme NL + 1,5g KCl

- 6-24h: SG 5% (2L)
+ 2g NaCl + 1,5g KCl dépend ionog

Si: Fièvre $\Rightarrow$ Parfalgan 18h

infec $\Rightarrow$ Claforan 2x1j / 12h

* Insulinothérapie = IV jusqu'à 24h/cc =
50cc SST + 0,1 UI/kg/h

Si: pas cc $\Rightarrow$ Parse sc / 1h.
10UI IO en sc / h

Glycémie 2h $\rightarrow$ SST SG 5%
après 2h $\rightarrow$ SG 10%

Gly > 2,5 $\Rightarrow$ SG 9%
1,5 { Gly < 2,5 $\Rightarrow$ SG 5%
Gly < 1,5 $\Rightarrow$ SG 10%

Tonogramme
chaque 2h

$X \leq 3 \text{ mmol/l} \Rightarrow \text{KCl } 2 \text{ g/l ds } 2 \text{ h.}$
 $3 < X < 4 \text{ mmol/l} \Rightarrow \text{KCl } 1,5 \text{ g/l}$
 $X > 4 \text{ mmol/l} \Rightarrow \text{KCl } 0,5 \text{ g/l}$
 $5,5 \text{ mmol/l} \Rightarrow \text{Pas.}$
 $6,5 - 7 \text{ mmol/l} + \text{Anomalies d'ECG} \Rightarrow \text{Rea!}$

1er inf $\Rightarrow 15 \text{ UI par ex } 15\% \times 2 = 8.$

08 UI 10 en IVD

07 UI 10 en IM pas SC $S = CC \oplus$

ou 100 UI 1h en IVD + KCl $\rightarrow$ inf 1h

$$\text{Débit} = \frac{\text{quantité}}{\text{temps (h)} \times 3}$$

(15)

* Convulsion chez enfant :

- Clinique : inconscient, cyanose à la face,
⇒ PLS / O₂ thérapie ou 2 l/min si masque et l/min
Dextro / T° / Voie d'abord
- ⇒ Valium (Diazépam) en Intra Rectale
0.5 mg/Kg
2 min - 5 min si : Pas d'Amélioration
" 2ème Valium 0.5 mg/Kg en IR
" 3ème Valium 0.5 mg/Kg en IR
si : Pas d'Amélioration : en 2 - 5 min
⇒ Gardénal (Phéno-barbital)
0.2 mg/Kg max 40 mg 15 min
dans 150 mg SG 5% ou SSI en IV
⇒ Rechercher la cause si : fièvre ⇒ foyer
si : infec ⇒ Augmentin 0.1 ddp 2x1j
pas de foyer ⇒ TLT + ECBU
si : infec ⇒ Orokem 0.1 j
0.1 ddp 2x1j
si : Trauma ⇒ Scanner!

Si = Apyrétique + crises $\Rightarrow$ Avis Neuro!
EEG + TDM.

Depakine $\xrightarrow{\text{QSP} = 0.5 - 0.7 \text{ g}}$
 10 mg/Kg/j en attendant consultation
Neuro!

* Convulsion apyrétique $\Rightarrow$ TA + Bilan Métab
ionog $\rightarrow$ + Ca + Mg + glycémie + FO +
TDM $\Rightarrow$ Tit de cause.

* Convulsion pyrétique $\Rightarrow$ PL + EEG si =
crise complexe $\Rightarrow$ TDM + IRM.

NB = Diazepam est CI chez l'enfant
 $\Rightarrow$ G. Ordinal 20 mg/Kg ds SSI $2 \times 1 \text{ g}$

* Déshydratation aigue de l'enfant:

- Clinique = pli cutané, yeux cernés, hypotonie, perte du poids, soif, sécheresse muqueuse, $\Rightarrow$ glycémie / ionogramme sanguin et urinaire / Urée / Créat / K^+ (si diarrhée / Vomissements)

- * Yeux cernés + Fontanelle déprimée $\Rightarrow 5\%$
- * Yeux cernés + FA + plie cutanée $\Rightarrow 8\%$
- * YC + FA + PC + TRC $\Rightarrow 10\%$
- * YC + FA + PC + fièvre $\Rightarrow 10\%$ $\ominus$ 2 ans
- * YC + FA + PC + Soif $\Rightarrow 10\%$
- * YC + FA + PC + Trouble neuro $\Rightarrow 15\%$
(Coma / Convulsion)

ou
$$\frac{\text{Poids récent} - \text{Poids (Nau)}}{\text{Poids Récent}} \times 100 = \%$$

* Réhydratation:

- $5\% \Rightarrow 90\%$: SRO 50 cc/Kg en 4h
- 8% Amélioration $\Rightarrow$ Libérer malade
100 cc / Kg 4h - 12h - 24h

- 5-10% $\Rightarrow$ $VO = SRO$ 100 cc / Kg en 4h
 $\oplus$ 4h si: Amélioration $\Rightarrow$ Libérer malade
- 10% $\Rightarrow$ $VO =$ si possible SRO 100 cc / Kg en 4h
 $\ominus$ dans csc 3min $\oplus$ dans ds vend 3min
 pas possible VO $\longrightarrow$ IV
 si: Diarrhée freq / Vomissements incessants
 TRC > 4 sec / Trouble Nervo $\Rightarrow$ $\oplus$ IV

* CAP:

- 0-30 min: 20 cc / Kg SSI
 ex: 5Kg $5 \times 20 = 100$ cc / 30 min
- 30-2h: 30 cc / Kg SSI / 4,5
 Débit = $\frac{30 \text{ encc}}{3 \times \text{temps(h)}} = \text{gtt/min}$

- * Enfant pas uriné = 10 cc / Kg SSI en 1h
 Renouveler une fois
 Lasix 1mg / Kg en IV $\Rightarrow$ Réal si uriné
- $\Rightarrow$ Au moment où il uriné on continue
- 2-6h: 50 cc / Kg SIR = 12 = Débit /
 tous ça c'est les pertes antérieures / gtt / min
- 6-12h: 50 cc / Kg SIR = 18 = gtt / min
 Pertes en cours!
- $\rightarrow$ Malgré Lasix si pas uriné $\Rightarrow$ Réal
 insuffisance rénale

Ratio de base :

• 12 - 24 h =

0 - 10 Kg $\Rightarrow$ 1000 cc/Kg / 5 dans 12 h = 20

$$10-20 \text{ Kg} \Rightarrow 1000 + 50 \Delta \text{cc} 1 \text{ Kg} \quad \div 36$$

على كل ١٠ مئوق ١٠ ح لئ قئع ١٠

$$\textcircled{+} 20 \text{ Kg} \Rightarrow 1000 + 500 + 20 \text{ cc/kg} = 36$$

على كل واحد الحقوق 10 > 10 ② < 10 السوية ④

* ionogram = Hypo Na δ^- Na $\left\{ \begin{array}{l} 120 \\ 110 \end{array} \right.$

⇒ Das urine : Supplementation

10 cc/kg de SSI / 100 g

$\Rightarrow$ Minère complète le schéma

* $S_i = S/R$ en manque

$\Rightarrow$ SG 5% + 2 meq Na / 100cc

chaque degré au de la de 38°C

on ajente 10 cc/kg + Perfalgan inj

* En cas de collapsus: Hypotension

20 cc SSI 1Kg en 20min

* Fièvre à 40°C :

⊖ sans risque de convulsion brut. $> 39^{\circ}\text{C}$
⇒ Paracétamol suppo

+ Dose de charge 25mg/Kg
moyen physique (poche de glace)

Si: $T^{\circ} < 39^{\circ}\text{C}$
Pas d'Amélioration

⇒ $12,5\text{mg/Kg}$ après 1-2h

Pas d'Amélioration

Aspirine inj 10mg/Kg en IM
ou Per ~~par~~ 1g en inj dans 5cc SS
Si: $T^{\circ} > 39^{\circ}\text{C}$ ⇒ Bilan préop

* 1 mois → 33Kg :

⇒ Paracétamol 15mg/Kg IV en perfusion

* ⊖ 1 mois :

⇒ $12,5\text{mg/Kg}$ T_j + moyens physiques
Pas d'Amélioration ⇒ (H)

Bilan PO: FNS / CRP / VS

⇒ THT de face

⇒ CU

⇒ ECGU + Antibiogramme

Rien → PL ⇒ Avis pédiatre!

* Crise d'asthme :

⇒ 01 Séance de Nébulisation

+ 01 cc Salbutamol + 03 cc SSI

+ 40mg Solumédrol en IVD

ou 200 mg HHC en IVD

Si : Pas d'amélioration après 20 min

⇒ 01 Séance de Nébulisation

+ 01 cc Salbutamol + 03 cc SSI

après 20 min Pas d'amélioration

⇒ 01 Séance de Nébulisation

+ 01 cc Salbutamol + 03 cc SSI

après 03 séances Si : pas d'Amélioration
ou aggravation

⇒ chaque 1h une séance 01 de
Nébulisation

⇒ 01 Séance de Nébulisation

+ 01 cc Salbutamol + 03 cc SSI

+ 015 mg Atrovent

Si : Pas d'Amélioration

⇒ 01 Séance de Nébulisation

+ 01 cc Salbutamol + 03 cc SSI

+ Sulfate de Mg diluée en 100 cc SG 5h
0.1g (0.1 Amp ou 1/2 Amp) en 15 min
Si = Pas d'Amélioration

⇒ Avis Pneumo!

• BPO = FNS / VS / CRP...

• TLT = pneumonie...

Si = Gêne sévère ou Pause resp
⇒ Avis Réa!

Si = Non Salbutamol en IV

+ Sulfate de Mg en 15 min

⇒ évaluation en Réa / Pneumo!

* Gêne modérée = (H)

⇒ 1 Séance de Nébulisation

+ 0.1 cc Salbutamol + 0.3 cc SSI / 6h

+ 40 mg Salbutamol 18h

ou 200 mg HHC 18h

Si = fièvre ⇒ Parfalgan 18h

Si = Pneumopathie ⇒ Amox my 1g / 18h

ou Augmentan my 1g / 12h

ou Claforan my / 12h

CAT

* Légère : Ventoline 2 bouffes / 20 min
Si : ça passe pas après 1h } modérée

* Modérée : Nébulisation 1cc Astalin dilué
dans 4cc SSI / 20 min
CTC (Salmédrol 1mg / Kg en IV)
Si : après 1h pas d'Amélioration } S

* Sévère : Nébulisation 0,03 cc / Kg Salmoband
dilué dans 4cc SSI
CTC (Salmédrol 1mg / Kg
ou Dexa 0,5mg / Kg) + O₂

CAT

* Légère : Nébulisation 0,5 cc Salmoband < 16 Kg
ou 1cc > 16 Kg + 3cc SSI

* Modérée ou sévère : Nébulisation
+ Salmédrol inj IV 1mg / Kg
On fait 03 séances de Nébulisation
chaque 20 min et on réévalue
à la sortie :

- 1) - Ventoline Spray 2 bouff 3x1j pdr 07j
- 2) - Salmédrol cp 10mg / Kg matin
pdr 05j

+ Bronchiolite chez enfant:

- Clinique = Dyspnée expiratoire, Toux Asmatiforme
 ⊖ dans Bronchiolite ⊕ dans Début asthme
 Raies Stridements.

* PDF = 01 Séance de Nebulisation } pdt
 + 0,03 mg/Kg Salbutamol (Asthalin) } 20
 + 03 SST ex = 10 Kg x 0,03 = 0,3 } min
 Si : Amélioration ⇒ Trk de Sortie

Ordonnance:

- 1/ - Salbutamol sirop _____ 0,03 mg/Kg
 01 cà m 2x/j
- 2/ - Célestène gtt _____ 0,05 mg/Kg
 10 gtt / Kg/j le matin
- 3/ - Prima-lan sirop _____ 01 flacon
 01 cà m/j le soir
- ou Totinal sirop _____ 01 flacon
 01 cà m/j le soir
- ou Histagan sirop _____ 01 flacon
- ou Deslor sirop _____ 01 flacon
 01 cà m/j le soir

Si Pas d'indication $\Rightarrow$ 2^{ème} séance
 $\Rightarrow$ 0,03 CC Salbutamol + 03 CC SSI en dernière
 Si Pas d'Amélioration $\Rightarrow$ 3^{ème} séance
 $\Rightarrow$ 0,03 CC Salbutamol + 03 CC SSI + CTC
 . CTC $\Rightarrow$ Celestène glt
 10 gtt / kg sur place
 ou Salume Inal 2 mg / kg en IM sans dépasse 40
 ou HHC 5 mg / kg Dose Max 200 mg IM

Si: 03 Séances Non Réponse $\Rightarrow$ (H)
 Bronchite + 03 mois $\Rightarrow$ (H)
 Bronchite Sévère $\Rightarrow$ (H)

Cardiopath / Malnutrition ...
 Si: TLT anormal $\Rightarrow$ Avis pédiatrie!

Salbutamol sirop Φ SP = 05-07j
 1/2 càc 2-3x/j Si 01 mois - 2 ans
 01 càc 2-3x/j 2 ans - 6 ans
 01 càc m 3x/j 6 ans - 12 ans
 (H) $\Rightarrow$ Bilan: FNS / glycémie / TP / Urée / Créat
 ionogramme S 1 CU
 $\Rightarrow$ TLT de face $\Rightarrow$ ECBU.

* Constante initiale chaque 2h = FR - FC - SnO_2
24h $\Rightarrow$ Diurèse / poids
 O_2 thérapie / Arrêt d'alimentation orale,
Aspiration 14h au @ 24h

$\Rightarrow$ Séances de Nébulisation 16h
0,03 cc Salbutamol + 0,3 cc SSI

Si = fièvre $\Rightarrow$

ATB = Claforan 100mg/Kg/j 16h 4x/j IV

CTC = HHC 500mg/Kg/6h

$\Rightarrow$ Rehydratation (voir b schémas !)

CTC = Matin à jeun AH = Soir

* Laryngite chez l'enfant :

• Clinique : Dyspnée inspiratoire / Raie / Voix rauque

* PDI : 0,6 mg Dexa en IM Dose max = 12 mg

Si : Amélioration $\Rightarrow$ Trt de sortie

Si : Pas d'Amélioration après 01 h

$\Rightarrow$ Dexa 0,4 mg en IM

Si : 01 h après pas d' (H)

$\Rightarrow$ 01 Séance de Nébulisation :

01 cc adrénaline + 2 cc Dexa + 3 cc S

Si : Amélioration $\Rightarrow$ Trt de sortie

Ordonnance :

1) - Celestène gtt _____ QSP : 05 j
10 gtt / Kg ex : 10 Kg $\Rightarrow$ 100 Dose Max : 200 j

ou
= Sclupred cp 5-20 _____ QSP : 05 j
02 mg / Kg / j le matin DM = 40

2) - Augmentin susp _____ QSP : 10 j mg
01 ddp 2x / j

Si : Non Réponse sort (H) ou Avis pédiatre !

* Sinusite aigüe :

- Cliniques : obstruction nasale, douleur, écoulement purulent. Muin ou bñ poster bñ à palpation
- * PDF : Rx de maxillaire faciale : opacités confirmées → PDM
- en urgence ⇒ 01 flacon perfalgan 15 min
ou 01 Amp Chefenol en 1H
+ O₂ thérapie 5-10 min
ou Pamogésic 1/2 Amp } Rare.
ou Valium 1/2 Amp }

Ordonnance :

- 1) - Augmentin 1g ——— GSP = 10j
01 cp 3x 1j
- 2) - Nifluril gtt 250 ——— 01 Hc
(AH) 01 gtt 2x 1j au milieu repas
- 3) - Proton gel 20 mg ——— 01 Hc
01 gel 1j

* Angine de l'enfant :

P = 10 Kg 2 ans
 Fièvre = Motif +++ • examen de gorge = Angine

Ordonnance :

1) - Clamoxyl sup 125/250/500 ——— Dose 10j
 $50 \text{ mg/Kg} \times 10 = 2 = 250$ 2-3 x 1j
 1 cà m 2 x 1j

2) - Paracétamol sup 1 sup / sach 100/150/200/300
 $50 \text{ mg/Kg} \quad 500 = 2 = 250$

3) - Algifen sup ——— 01 flacon

AI + ✓ 01 ddp (10 Kg) / 8h

Antipyrétique en Alternance avec paracétamol

* Angine + Fièvre + Vomissements

1) - Clamoxyl sup 250 ——— Dose 10j
 01 cà m 2 x 1j

2) - Domperidone sup ——— 01 flacon
 Vomss 01 ddp 2 x 1j 1/4 h avant repas

3) - Paracétamol sup ——— 0 1 bte
 01 sup 18h

4) - Algifen sup ——— 01 flacon
 01 cà m 18h en Alternance avec Paracétamol

* Angine + Fièvre + Douleur Abdominale

1/ - Clamoxyl 2/ - Paracétamol susp

Douleur { 3/ - Smecta sachet 01 sachet 2x tj
01 sachet dans 01 l d'eau.

Douleur Abdominale ⇒ 5/ - Débridat susp 01 flacon
01 cam 2x tj

Si: Angine + Fièvre et malade le 1er
la T = 38.5 °C soit: pas d'Angine ou
Amox non efficace.

Ordonnance:

1/ - Augmentin susp 01 ddp (10 Kg) 2x tj
QSP: 10g

2/ - Efferalgan susp 01 cam 1 bh
01 flacon

Douleur de gorge ⇒ 3/ - Maxilase susp 01 cam 3x tj
01 flacon

* Angine + fièvre + Allergie aux Pén
 1) - Josacine sup 250 ——— QSP = 10j
 ↓
 olcām 2x1j
 ou Zedac sup 25/50 ——— QSP = 5j
 ↓
 olddp 2x1j ⊖ 25 Kg ⇒ 25 ⊕ 25 ⇒ 50
 ou Rovamidal sup 37500 U1 ——— QSP = 10j
 ↓
 olcām 2x1j

* Angine 2 ans ⊖ ⇒ 90% virale
 1) - Efferalgan sup ——— 01 flacon
 ↓
 olcām 18h

2) - Eau de mer
 enter ATB sauf si = fièvre > 3j

* Après 4 ans si =
 Angine à Répétition ⇒ bilan
 ASLO (+) si > 200

Extraitine pour lutter contre RAA

1) - Extraitine 0,6 M ⊖ 30 Kg 03 inj
 1,2 M ⊕ 30 Kg
 01 inj / 21j en IM stricte

 dans un milieu hospitalier
 disponible : O₂ / Adrenaline / CTC
 solumedrol ou HHC IV

* Angine chez Adulte :

- 1/ - Clamoxyl 1g ——— QSP 07j
 01 cp 2x 1j
- 2/ - Paralgon 500 ——— 01 1/2c
 01 cp 3x 1j
- 3/ - Vit C cp ——— 01 1/2c
 01 cp 1j le matin
- 4/ - Hexaméryl ——— 01 glucan
 01 ——— 3x 1j - medepan pas 05j
- ou Maxilase sup ——— 01 glucan
 01 cà m 3x 1j
- ou Augmentin 1g
- ou Amoxiclan Bich
 01 cp 2x 1j
- ou Lexin 1g
 01 cp 2x 1j
- si = fièvre $\nearrow \nearrow$
 $\Rightarrow$ Amox mg 1g

* Covid 19 :

- clinique : fièvre, Toux, myalgies, dyspnée, perte de goût et odeur, cas similaire...
- FDR $\Rightarrow$ (H) pas FDR $\Rightarrow$ Trt Ambulatoire

ou Tests :

- ① * Test rapide Antigénique Covid 19
Si (+) confirme le Dg peut (-) après 5-7 j de sympt.
 - ② * Test R-T PCR Covid 19 (-) + j
 - ③ * Sérologie Covid 19 IgM + IgG.
 - ④ * TDM Thoracique Recente Ancienne
- Suivi jour $\Rightarrow$ Trt de Soins

Ordonnance :

- 1 - Augmentin cp 1g ——— 01 cp 2x 1j 01 bte 10j
- 2 - Zomax cp 250 ——— 02 cp 1j 1er j 01 cp 1j le reste des 4j 01 bte 5j
- 3 - Vit C cp ——— 01 cp 1j le matin 01 bte
- 4 - Zinc cp 10mg ——— 01 cp 1j 01 bte

51 - Mg Amp $\xrightarrow{01 \text{ Amp } 2 \times 1 \text{ j}}$ 01 Lte

61 - Vit D Amp $\xrightarrow{01 \text{ Amp } 2 \times 1 \text{ j}}$ 02 Lte

* Sujet = HTA / Diabétique / Cardiopathologie
 $\Rightarrow$ (H) pas CTC avant 07 j $\text{SaO}_2 < 92\%$
 $\Rightarrow$ O_2 thérapeut / ATB / CTC / Anticoagulant
Hydroxychloroquine 200.

$\Rightarrow$ Bilan = FNS / glycémie / VS / CRP / Urée /
Créat / ASAT / ALAT / ionogramme / D-D

• O_2 thérapeut 08 - 10 l dépend SaO_2
30 l si 92% ou $\ominus \Rightarrow$ ARIS Rén 1

• ATB si = fièvre $> 38^\circ$, CRP > 17
réapparition de fièvre, Taux persistante

Augmentin 1g mg $3 \times 1 \text{ j}$ pdr 10 j
ou Claforan 1g 500 mg pdr 10 j 1g/8h
ou Ciprofloxacine 200 pdr 10 j
dans perfusion 1h $2 \times 1 \text{ j}$

• Anticoagulant: Lovenox si = DD > 500,
 IMC > 25, adulte, Md chronique
 Lovenox 0,4 en sc 1x1 ∇ QSP: 10j
 IMC < 30 $\Rightarrow$ 0,4
 IMC > 30 $\Rightarrow$ 0,6

ou injecter 3500 UI < 30 kg
 7500 UI > 30 ∇ 2xj
 QSP: 10j jusqu'à 01 mois si = maladies
 si = DD $\ominus$ 500 $\Rightarrow$ Arrêt Lovenox
 si = DD $\uparrow\uparrow$ on $\uparrow$ la dose si men $\Rightarrow$ Avis Cardia
 100 UI/Kg chaque 12h pour Lovenox
 175 UI/Kg chaque 24h par injecter
 • Bilan chaque 3-5j:
 FVS / VS / CRP / Mée / Créat

* CTC après QSP: 5-10j
 Solumédol 40mg en IV/12h 2xj
 ou Dexa 0,4mg Amp 0,1-0,2mg/Kg/j
 ou Schupred 8mg 0,75-1,2mg/Kg/j
 sans dépasse 32mg

* Diarrhée Aigue : Liquide glauqueuse

① * Diarrhée aigue liquide :

1) - Smecta Sachet _____ 01 Lte

- 2 ans 1/2 Sachet 2x1j
 2 - 6 ans 1 Sachet 2x1j
 + 6 ans 1 Sachet 3x1j

+ SRO.

2) - SRO sachet _____ 02 sachets
 01 sachet dans 01 l d'eau.

5% 50cc / Kg 1j

10% 100cc / Kg 1j

Si : Pas d'Amélioration

1) - Tiorfan Sachet 10/30 _____ 01 Lte

10 (1 mois - 9 mois $\Rightarrow$ 1 sachet 2x1j
 9 mois - 30 mois $\Rightarrow$ 2 Sachets 2x1j

30 (30 mois - 9 ans $\Rightarrow$ 1 Sachet 2x1j
 + 9 ans $\Rightarrow$ 2 Sachets 3x 2x1j

2) - SRO _____ 03 Sachets

01 sachet dans 01 l d'eau.
 chaque diarrhée un sachet.

②* Diarrhée glairo-sanglante : ATB
 1/ - Bactrim sup 240 ——— QSP : 07 j
 01 cam $2 \times 1j$
 $30 \text{ mg/Kg/j} = 2 \text{ fois} = ?$

2/ - Flagyl sup 125/250 ——— QSP : 07 j
 (Métronidazole) 1 cam $2 \times 1j$
 30 mg/Kg/j

3/ - SRG sachet ——— 02 sachets
 01 sachet dans 01 l d'eau.

8 : fièvre $\rightarrow$ (H)
 (entre Smecta) n'arrête pas la diarrhée

$\rightarrow$ 1/ - Flagyl inj 12h
 $20 \text{ mg/Kg/j} = 2 \text{ fois} = ?$

2/ - Bactrim 30/6 perfusion

0,2 cc/Kg = 2 fois $2 \times 1j$
 ou Ampicilline inj 100 — 120 mg/Kg/j
 12h $2 \times 1j$

ou Augmentin

ou Claforan

3/ - Perfusé pédiatrique 18h.

* Epistaxis chez l'enfant :

- POF : Mèche nasale + 1 -
1/2 Amp Dicynene IV
ou 1/2 verre eau ou en IM.

Ordonnance :

1 - HEC pde _____ of tube

ou app 2x1
à Répétition :

Bilan : FNS (playmets) / TP / TCK / prise TA

Si : (A) ↙
Si : chronique $\Rightarrow$ Avis ORL!

* Urticaire :

- Clinique : Contours nets, prurit, vaille #, relief bombé, d'origine médicamenteuse.

* PDF :

- 40mg Solumédol en IV 1h
- Pas amélioration : 200mg HHC en IV 30'
- Pas amélioration : AH
- 01 Amp phénergan en IV

Ordonnance :

- Telfast
1/ - Telfast 180 _____ 01 bte
(AH) 01 cp / j le soir
- Resp Cutané
120 180
2/ - Solumédol 20 _____ 01 bte
(CTC) 02 cp / j le matin
- ou
1/ - Zyrtec gtt _____ 01 flacon
20 gtt le matin (E) 10 gtt
- 2/ - Titalin cp _____ 01 bte
01 cp / j le soir
- Enfant :
⊖ 2 ans Primaban 01 cà c / j le soir
⊕ 2 ans Zyrtec 10 gtt le soir
Clarytine sup 01 cà c / j le soir
⊕ 6 ans même que Adulte

* Zona :

⇒ éruption en bande vésiculeuse.

Ordonnance :

1/ - Aciclovir cp 800 _____ GSP = 07-10g

01 cp 5x1j 4mg1j

2/ - Fosine Aqueuse sol _____ 01 flacon

01 Appl1j

3/ - Dolyc 1g _____ 01 bte

Douleur 01 cp 3x1j

2ème CAT :

1/ - Aciclovir cp 800 _____ GSP = 10g

02 cp 2x1j

2/ - Aciclovir pde _____ 01 tube

01 Appl1j

3/ - Xamadol cp _____ 01 bte

01 cp 2x1j

3ème :

1/ - Aciclovir cp 01 cp 5x1j GSP = 10g

2/ - Fosine Aqueuse sol 01 Appl1j 01 flacon

3/ - Tramadol cp 01 cp 2x1j 01 bte

ou Tegre sol 200 cp 01 cp 1j 01 bte

ou Zyrica 150 01 cp 2x1j 01 bte

4/ - Neurvit B₁ B₆ _____ 01 bte

01 cp 2x1j (41)

* Hélopathies fonctionnelle :

Diarrhée $\Rightarrow$ Coproparasitologie des selles

Constipation $\Rightarrow$ TSH, FT_3 , FT_4

Douleur localisée $\Rightarrow$ échographie Abd

Diarrhée fréq - te $\Rightarrow$ Md Coeliaque

Dosage IgA antendomysium

* Trt en urgence : Anxiété

$\Rightarrow$ 01 Amp Prümperan (calmer / Antémétique)

ou 01 Amp phenergan en IM + O_2 therapy

ou 01 Amp Sparfon en IM

Ordonnance :

1) - Sparfon cp _____ 01 bte

01 cp 2x1j

2) - Detsudat cp 200 _____ 01 bte

01 cp 2x1j

ou Dusphtakalin gel 200 _____ 01 bte

01 gel 2x1j

ou Transacalm gel 200 _____ 01 bte

01 gel 2x1j

Constipation $\Rightarrow$ 3/ - Duphalac sachet _____ 01 Lte
ou 01 sachet 2x1j
ou Ezilax sup _____ 01 flacon
01 cās 2x1j

Diarrhée $\Rightarrow$ 4/ - Imodium gel 2mg _____ 01 Lte
02 gel 1j

après chaque diarrhée peut $\oplus$ 01 gel.

Anxiété $\Rightarrow$ 5/ - Zysanxia cp _____ 01 Lte
1/2 cp 1j le soir

Trouble de $\Rightarrow$ ou dia-tyl cp _____ 01 Lte
Sommeil 1/2 cp 1j le soir

Dépression $\Rightarrow$ 6/ - Isoptyl gtt _____ 01 flacon
peur $\Rightarrow$ ou Laroxyl gtt

03 gtt 1j le soir
7/ - Escal cp _____ 01 Lte
01 cp 1j le soir

faussement $\Rightarrow$ Béchilix sachet _____ 01 Lte
gastroq 01 sachet 2x1j

gaz $\Rightarrow$ Eucarbon 01 cp _____ 01 Lte
01 cp 2x1j

Charbone plus cp _____ 01 Lte
01 capsule 2x1j

spasme ou Méthéoxan gel _____ 01 Lte
01 gel 2x1j (43)

* Colique Néphrétique :

- Colique : Douleur unilatérale, fosse lombaire, agitée, pas position antalgique, insupportable, irradie vers OGE, pas fièvre.

but : Soulager la douleur

⇒ Clofenal ou Amp en IM 3-7 min

si : pas d'amélioration

⇒ Perfusion ou flacon de perfalgan à flow

si : pas d'ⓐ

⇒ Tramgésic en SC

PDF : * Labstix : infec, sang ⇒ CN

⇒ frapper le dos en regard du rein
dédouleur de la douleur

* ECBU

* échographie

Ordonnance :

1/ - Clofenal 50 _____ 01 bte

ou Feldene inj 20 _____ 01 bte
3x 1j au milieu repas
01 inj 1j en IM.

ⓐ si : CN hyperalgique ⇒ Avis Mal
pyélique 38.5°, oligo Anurie
Femme enceinte ⓐ

* Pathologie Hépatique

Clinique : Douleur en regard du foie, HD super après repas lipide inachève vers haut clavicule CN, dg ≠ (inachève vers OGE poche chaud)

Labo : RAS x

⇒ O₂ thérapie / Voie d'abord

01 Amp Sparfon en IV

ou 01 flacon de perfalgan en IV 15 min

ou 02 Amp Sparfon dilués dans 150cc SSI ou SG 5% 30 min

Ordonnance

1 - Sparfon cp 200 ——— 01 bte
01 cp 2x1j

2 - Dérivé dat 200 cp ——— 01 bte
01 cp 2x1j 05j

ou Busphatatin gel 200 ——— 01 bte
01 gel 2x1j

ou Sparco gel 200 ——— 01 bte
01 gel 2x1j

Vomissement ⇒ Clopramide cp ——— 01 bte

Dompéridone cp ——— 01 bte
01 cp 2x1j 1/4h avant repas

(45)

Lettre échographie : chœ confie
Permettez-moi de vous adresser le
patie ~~à~~ son ~~no~~ ~~é~~, âgé de 2 ans
aux ATCD, qui consulte ce jour pour une
CH je vous le confie pour échographie
(H) Abd

* Bilan = FNS / VS / CRP / ASAT / ALAT / GT / PA
BT / B D / BE / glycémie

(H) si Douleur + Fièvre $\Rightarrow$ Cholécystite

$\downarrow$ Douleur + Fièvre + ictère $\Rightarrow$ Angiocholite

$\downarrow$ ATB + Avis chirurgie en Urgence.

sparfloxacin 18h

penicilline 18h

prémperan 12h

SSE 18h

Flagyl 500/12h

ATB { Ciprofloxacine 200 2x1j

[ou Bactrim ou Augmentin 1g 2-3x1j

ionogramme 3g NaCl + 2g KCl

CH simple $\Rightarrow$ échographie Abd.

$\Rightarrow$ Consultation

Angiocholite $\Rightarrow$ Avis gastroentéro
chirurgie!

* Guise hémorroïdaire :

PDF: 01 Amp Valavène en IM +++
 + 01 de spargon en IVB ou IM
 ou perfusion 1 flacon de perfalgan en IV
 + 01 Amp dofenal en IM

Ordonnance :

1/ - Duflo cp 500 _____ QSP: 01 mss

02 cp 2x1j - pdr 10j
 01 cp 2x1j - le reste ds j

2/ - Tikanoréine à lidocaïne supp - 014te
 01 supp 1j - le soir

3/ - Tikanoréine à lidocaïne pde 2/ - 01 tube

01 App 1j

constipation ⇒ 4/ - Duphalac Sachet _____ 014te

01 sachet - 1-2x1j

Antalgique ⇒ 5/ - Divido 75 _____ 014te

01 cp 1j - le soir

2e Ordonnance :

1/ - Diovonor cp 600 _____ QSP: 01 j

01 cp 3x1j

2/ - Hémorect crème _____ 01 tube

01 App 1j

3/- Permanganate de potassium $KMnO_3$ cp - 01 lte
01 cp 1 2P pour bain de siège

4/- Ezilax sup _____ 01 flacon
01 càc 2x 1j

Antalgique => 5/- Rapidos 50 _____ 01 lte
01 cp 2x 1j au milieu repas

~~3^e ordonnance :~~

1/- Veïnasmil gel 200 _____ 02 sps 1j
2 gel 2x 1j

2/- Hemobog crème _____ 01 tube
01 Applj

3/- Hemobog sup _____ 01 lte
01 sup 1j le soir

4/- Poncture l gtt _____ 01 flacon
06 gtt 1j

5/- Clofenal cp 100LP _____ 01 lte
01 cp 1j au milieu repas le soir

~~4^e ordonnance :~~

1/- Cyclo 3 fat gel _____ 01 lte
02 gel 2x 1j

2/- Néo-healer pte _____ 01 tube 01 Applj

3/- Trimebutine sup _____ 01 lte 01 sup 1j

4/- Voltarène cp 50 _____ 01 lte 1 cp 2x 1j
au milieu repas

* Infection urinaire :

Clinique : Brûlure mictionnelle ++, dysurie --

* PDF : Labstix

⇒ Sang, protéine +/-, Nitrite (+), Leucocytes⁽⁺⁾

Ordonnance : Femme

1 - Mircare sachet 3g _____ ol lte

ol sachet 1j

ou Norfloxal cp 400 _____

ol cp 1j

QSP 803j

si = persistance ds symp

⇒ ECBU + Antibio

Ordonnance : Homme

1 - Bactrim cp _____

ol cp 2x1j

QSP 07j

2 - Nitroal cp 100 _____

ol cp 3x1j

QSP 07j

3 - Dolyc 1g _____

ol cp 2x1j

ol lte

ou Clafenal cp 50 _____

ol cp 2x1j

ol lte

pdr 3 - 5j au milieu repos

Antiseptique
urinaire

Si = Persistance de symp $\Rightarrow$ ECBU + Anti

ATB =
 pas d'exercices
 forces
 régime de
 l'endurante

1) - Ciprolan 500cp
 01cp 2x1j φ SP = 10j

2) - Nitrofur 100cp
 01cp 3x1j φ SP = 07j

3) - Chloramphenicol 50cp
 01cp 2x1j au même repas
 014te

1) - Chloracel 500cp
 01cp 2x1j φ SP = 10j

2) - Nitrofur 100cp
 01cp 3x1j pdr 07j
 014te

3) - Delysc 1g
 01cp 2x1j
 014te

1) - Bactrim cp
 01cp 2x1j φ SP = 07j

2) - Nitrofur cp 100
 01cp 3x1j 014te

3) - Rapichlor cp 50
 01cp 2x1j 014te

1) - Lexin 1gcp
 01cp 2x1j φ SP = 10j
 (50)

1/ - Augmentin 1g _____ QSP = 10g
01 cp 2x 1g

2/ - Nitrofur cp 100 _____ 01 bte
01 cp 3x 1g

3/ - Rapinidur cp 50 _____ 01 bte
01 cp 2x 1g

• Femme enceinte

* 1/ - Clamoxyl 1g cp _____ QSP = 10g
01 cp 2x 1g

ou Augmentin

ou Cloracef 500 cp _____ QSP = 07g

ATB prescrit $\Rightarrow$ Croken 200 cp _____ QSP = 10g
01 cp 2x 1g

* Enfant 30 mois - 12 ans (100) 6 mois - 30 (40)

1/ - Croken 40/100 (0.8 mg/kg/g) 2x 1g

2/ - Paracétamol suppr _____ 01 bte 01 suppr

ou 1/ - Bac trim suppr 240 _____ QSP = 7g

1^{re} épisode dsz garçon $\Rightarrow$ Avis pédiatrie en Cystométrie

2^{ème} épisode dsz fille ds même année $\Rightarrow$ Avis pédiatrie! $\uparrow$
 $\Rightarrow$ Ht infection urinaire ds enfant $\uparrow$

* Morsure par un animal

- * pas de lésion ni atteinte de membre $\Rightarrow$ Rien
- * Morsure / griffure / Léchage / att. membre $\Rightarrow$ VAR + Soins locaux

① / * Petite lésion = VAR + VAT

I₁ I₂ I₃ I₄ I₅ I₆ I₇

en SC périmétrical

- Adulte + enfant > 5 ans $\Rightarrow$ 0,2 cc en SC
- enfant < 5 ans $\Rightarrow$ 0,1 cc (1/2 Amp)

+ ATB =

Adulte $\Rightarrow$ Augmentation cp 1g $\xrightarrow{2 \times 1g}$ $\text{QSP} = 10g$
0,1 cp

Enfant $\Rightarrow$ Augmentation sup $\xrightarrow{2 \times 1g}$ $\text{QSP} = 10g$
0,1 dd/p

δ^- = chien malade

$\hookrightarrow$ Rappe $\xRightarrow{I_{10}}$ I_{11} I_{15}
en intradermique

Ⓐ + Ⓔ > 5 ans $\Rightarrow$ 0,2 cc en ID en 2 points

Ⓔ < 5 ans $\Rightarrow$ 0,1 cc en ID

• Rappel: T_{30} T_{90} $\Rightarrow$ en ID si = Grande lénax (Saurage)

Sans locaux + VAR + SAR

flacon complet au nr du plaie

ou T_1

T_7 dans un jour parmi ces 7 après devent?

* Ferme enceinte $\Rightarrow$ VAR + SAR pas I ma eff.

* Piqure de Scorpions

O_2 thérapie 10-15 min

+ 40mg Sotumédol en ID 2-4h

* larence en Vit D₃

* Dosage demandé en cas :

- Md Ceatrague - Md de Grehn - RCH
- Stéatose hépatique - insuff hép
- Depakine / Tegretol / Phénobarbital

⇒ Malabsorption ⇒ Trt préventif

01 Amp de Vit D₃ 03-06 mois

* Chute sujet âgé / insuff Renale / Rachitisme ostéomalacie

01 Amp de Vit D₃ chaque 03 mois

Vit D₃ normal > 30 ⇒ Rien

20-30

⇒ 01 Amp D₃ / mois
pdt 02 mois

< 20 ⇒ 01 Amp D₃ 1/15

Amp 200.000 UI

pdt 2-3 mois

* Œdème de Quinck :

• Clinique = fièvre, urticaire, œdème aux v. usages
levées ↑ volume, palais gonflé

⇒ Thérapie / voir d'abord / TA / T°.

en urgence : 40 mg Salumédrol en IVD

ou 200 mg HHC en IVD

+ 01 Amp de phenergan en IM 1-2h

Ordonnance : CTC / 6h.

1 - Telfast cp 120 ——— 01 h/c

01 cp / j le soir

2 - Supradin cp 20 ——— GSP = 05 j

02 cp / j le matin

Si = 40 mg Salumédrol après 1h pas d'ⓐ

⇒ 200 mg HHC en IVD

Si = Dyspnée ⇒ 01 séance de Nebulisation

01 cc Adrenaline } 15 min
+ 03 cc SSI

ou 0,25 - 0,5 d'Adrenaline SC ou IM 15 min

0,25 d'Adrenaline en IM

Si = Non Réponse ⇒ ⓐ en médecine interne
ou Avis Réel!

* Impétigos

⇒ infection bactérienne de la peau autour des orifices, couleur de miel ⇒ éruption
CRP = 0 Atteinte Rénale (GMA) Score de 0 à 5
L → TA ↑, Labstix ou CU (protéines)

Ordonnance :

- 1 - Kéfolal sup 125/250 ——— DJP: 10g
01 cam 2x1j 50mg/kg/j
- 2 - Fusidine pole ——— 01 tube
01 App 2x1j
- ou Hexamidine sel ——— 01 flacon
01 App 2-3x1j

* Kyste synoviale

⇒ femme +++ formation d'écoulement au vr pignet
confirmer par = échographie de parties molles

Ordonnance : Si : Docteur

1/ - Rapidos cp 50 ——— 01 Lte
01 cp 2x1j au milieu repas

2/ - Neurob B1 B2 ——— 01 Lte

01 cp 2x1j + Bandage
en Aris orthope ——— 6 mois au ☉.

différence
des nerfs

* Lumbago

فنت ثقيت يوكيت

- Cliniques Douleur vive, bas de dos, musculaire
↳ ne dépasse pas les genoux.

⇒ 01 Amp Voltène en IM
Si = CI 01 flacon paralgan en IV

Ordre de :

- 1/ - Dolyc 1g cp _____ 01 Ut
01 cp 3x1g
- 2/ - Voltène pde _____ 01 tube
01 Appl - 2x1g
- 3/ - Mydocalm cp 150 _____ 01 Ut
01 cp / j le soir

-
- 1/ - Rapidos cp 50 _____ 01 Ut
01 cp 2x1g au milieu repas
 - 2/ - Tabiflex col _____ 01 tube
01 Appl
 - 3/ - Keferlech par th _____ 01 Ut
01 par th / j
 - 4/ - Mydocalm 150 cp _____ 01 Ut
01 c / j le soir

* Lombosciatalgies :

- Clinique : Douleur lombaire + souffrance Neuro
 ↳ déposer les genoux + fessiers
 ⇒ 01 Amp Voltène en IM
 ou parafongum 01 flacon en IV.

Orda ce :

- 1) - Durodo cp 75 _____ 01 Lte
 01 cp 1j au milieu repas le soir
- 2) - Dolyc cp 1g _____ 01 Lte
 01 cp 2-3x1j DM = 6g
- 3) - Kefentech path ou Voltène p de
 01 path 1j 01 App 1j
- 4) - Hydorol cp 150 _____ 01 Lte
 01 cp 1j Fe soir

-
- 1) - Cycladol gpl 200 _____ 01 Lte
 01 gel 2x1j au milieu repas
 - 2) - Solumedrol inj _____ 2-3 inj
 01 inj 1j en IM

- estomac ⇒
- 3) - Antag 20 gel _____ 01 Lte
 01 gel 1j
 - 4) - Neurorib B₁ B₆ _____ 01 Lte
 - 5) - Dolyc cp 1g 2x1j 1cp 2x1j

- 1) - Clofenal cpo 01 Lte
 01 cp 2x 1j am milieu 1e pas
- 2) - Dolyc cp 1g 01 Lte
 01 cp 2-3x 1j
- 3) - Clofenal 2mg 02 mg
 01 mg 1j en 1M
 ou Feledene 20 mg 06 mg
 02 Amp 1j en 1M 1er j
 01 Amp 1j en 1M 2e j
- 4) - Voltale pde 01 tube
 01 App - 2x 1j

Si = Hyperalgique / paralysie / sd grave
 de cheval → Avis chirurgie!

* Torticolis :

Lum ——— bazo .
 haut ——— le
 ↑

- Clinique = Douleur l'ân du cou ⇒ faux geste

⇒ Diclofennac 75 en IV 01 Amp
 ou 01 flacon de peralgan en IV .

= Ordonnance :

- 1) - Zopam cp ——— 01 bte
 01 cp 2 x 1j au milieu repas .
- 2) - Mydocalm cp 150 ——— 01 bte
 01 cp 1j le soir

* Cervicobrachialgies :

- Clinique : douleur au nv du plexus brachial
irradie aux membre sup, progressive
+ souffrance Neuro
⇒ 01 Amp Clafenal en IV ou perfalgan

Ordonnance :

1/ - Xydol 400 _____ 01 ste
01 gel 2x 1 gel au milieu repas

2/ - Neurontin B₁ B₆ CP _____ 01 ste
01 cp 2-3x 1 gel

3/ - Clafenal pde _____ 01 tube
01 Appl

4/ - Probongel 20mg _____ 01 ste
01 gel 1 gel

1/ - Céliprex gel 200 _____ 01 ste
01 gel 2x 1 gel au milieu repas

2/ - Dolyc 1g _____ 01 ste
01 cp 2-3x 1 gel

1/ - Clafenal i/v 75 _____ 01 ste

ou Profund i/v 100 01 ste 1 gel en IV
ou Fealdene 01 i/v 1 gel en IV

(60)

* Cause de Migraine :

- Clinique : Douleur unilatérale pulsatile
- * PDF : O_2 5-10 min ou flacon peralgom 1 VD
 $\Rightarrow$ 01 Amp pramperan en IM
ou 1/2 Amp en IV diluée
- * PDF : $\Rightarrow$ 01 Amp Voltarene en IM
+ 1/2 Amp pramperan diluée en IV
ou peralgom + Voltarene

Ordonnance :

- sign $\rightarrow$ digestifs $\Rightarrow$
- 1 - Voltarene 50cp $\frac{01cp}{2x1j}$ $\frac{01ste}{01ste}$ ou milieu repas
 - 2 - Metoclopramide cp $\frac{01cp}{2x1j}$ $\frac{01ste}{01ste}$ 1/4 h avant repas
 - 3 - Dolyc 500cp $\frac{01cp}{2x1j}$ $\frac{01ste}{01ste}$

-
- 1 - Aspegic 500cp $\frac{01cp}{2x1j}$ $\frac{01ste}{01ste}$
 - 2 - Dolyc cp 1g $\frac{01cp}{2x1j}$ $\frac{01ste}{01ste}$

* Trt de fond:

1/ - Migranem cp ϕ SP 01 mois
et cp $3 \times 1j$ et 1/2

ou Summigran cp 01 1/2

ou Laroxyl gtt ϕ SP 1 mois

ou Seglor gtt / gel 10 gtt sér 2-3 mois
30 gtt $3 \times 1j$ 01 gel $3 \times 1j$

Début de $\rightarrow$ Relpax cp 01 cp à la demande
cuse
si: Trt inefficace $\Rightarrow$ Avis Neuro!

* Paralyse faciale périphérique

Si = central ou déficit Neuro associé $\Rightarrow$ TDM.

$\Rightarrow$ TA/T°/Dextro

* PDF = 40mg Solumédol en IVB ou IM.

ou 100mg HHC en IVB

ou 12mg Dexa en IM.

ordonnance

1 - Solupred cp 200mg cp 10g

2 cp/j le matin 5j

01 cp/j le matin 5j

Antiseptique 2 - Dacryo serum gtt

01 gtt 2x/j

01 flacon

Larmes artificielles 3 - Siccaguard gtt

01 gtt 3-4x/j

01 flacon

4 - Neurovit B1 B6

01 ste

5 - Pansement oculaire 01 j

+ Massages.

- 1) - Lomoxol 40 _____ $N^{\circ}=03$
 01 mg / j pdt 03 j matin
- 2) - Solupred 20 cp _____ 05 j matin
 01 cp / j
- 3) - Siccalfind gtt _____ 01 flacon
 01 gtt 4x1 j
- 4) - Dacryoserum gtt _____ 01 flacon
 01 gtt 2x1 j
- 5) - Neurivit B₁B₆ _____ 01 flacon
 01 cp 2x1 j

si: TA $\nearrow \nearrow$ $\rightarrow$ IDM.

si: $\vec{T} = 39^{\circ}, 40^{\circ}$ $\rightarrow$ pas de foyer
 $\rightarrow$ IDM $\rightarrow$ PL.

* Vertiges aigues :

⇒ O₂ thérapie / Dextro / TA / T°

ORL ()

Faux vertiges = anxiété ()

* PDF : O₂ + 01 Amp Tanganil 500mg IV
+ 01 Amp prümperan IV diluée en 1M

Ordre :

1 - Tanganil cp 500 01/4e
01 cp 3-5/5

Vomisse

2 - Prümperan cp 01/4e
01 cp 2x1g 1/4 avant repas.

TA ↑ → Risq AVC → Neuro
T° → pas foyer ⇒ TDM.
Céphalée (+) ⇒ TDM.

* PDF : FNS / glycémie à jeun / Urée / Créat
CT / TG / Urécémie

⇒ ECG (Anomalie coronarienne)

Si = signes de focalisation ⇒ Avis Neuro!

1 - Bitasec cp 01/4e
01 cp 2x1g

2 - Dompéridone cp 01/4e
01 cp 2x1g

- **Chalazion** : bord Normal, atteinte interne
- **Orgelet** : infectin deglande attbord
- **Blepharite** : bord inflammé en totalité

Ordonnance : Orgelet

1/ - Maxidrol collyre ——— 01 flacon
 Forakidex 01 gtt 3x 1j

2/ - Maxidrol pde ——— 01 flacon
 Forakidex 01 app 1j le soir

⇒ piquer avec aiguille le pus

Ordonnance : Chalazion

1/ - Cidermex pde ——— 01 tube
 01 App 1j le soir

2/ - Chibroxol gtt ——— 01 flacon
 01 gtt 3x 1j

Conjunctivite (bact / virale / allergique)

Ordonnance : Conjunctivite bact

⇒ gtt + pde (Maxidrol ou Forakidex)

ou

1/ - Chibroxime ——— 01 flacon
 01 gtt 3x 1j

2/ - Néomycine pde ——— 01 tube
 ou chloramphenicol 01 app 1j le soir

Ordon ce = Conjonctivite allergique.

1) - Naxia gtt _____ 01 flacon

01 gtt 3x 1j

ou Zevophta gtt _____ 01 flacon

01 gtt 3x 1j

ou Zalerg gtt _____ 01 flacon.

01 gtt 3x 1j

Primalan sup _____ 01 flac QSP=7j

01 cac 1j le soir

2) - Dacryosérum gtt _____ 01 flacon

01 instil 3x 1j

Ordo ce = Conjonctivite virale

1) - Rifamycine chlorhydrate gtt _____ 01 flac

01 gtt 3x 1j

2) - Rifamycine pdc _____ 01 tube

Neomycine pdc

01 App 1j le soir

3) - Dacryosérum gtt _____ 01 flacon

01 App 3x 1j

pas CTC

Ordon ce = Blepharite gtt

1) - Chlorobutol / Maxidrol collyre _____ 01 fl

01 gtt 3x 1j

2) - Sterdex / Maxidrol pmd _____ 01 tube

01 App 1j le soir

(69)

ou Tobrex gtt

01 gtt 4x 1j

ou Tobrex gel

01 App 2x 1j

↑

* Fracture de l'Humérus :

⇒ Soulager Douleur : 01 flacon de parafalgan 15 min

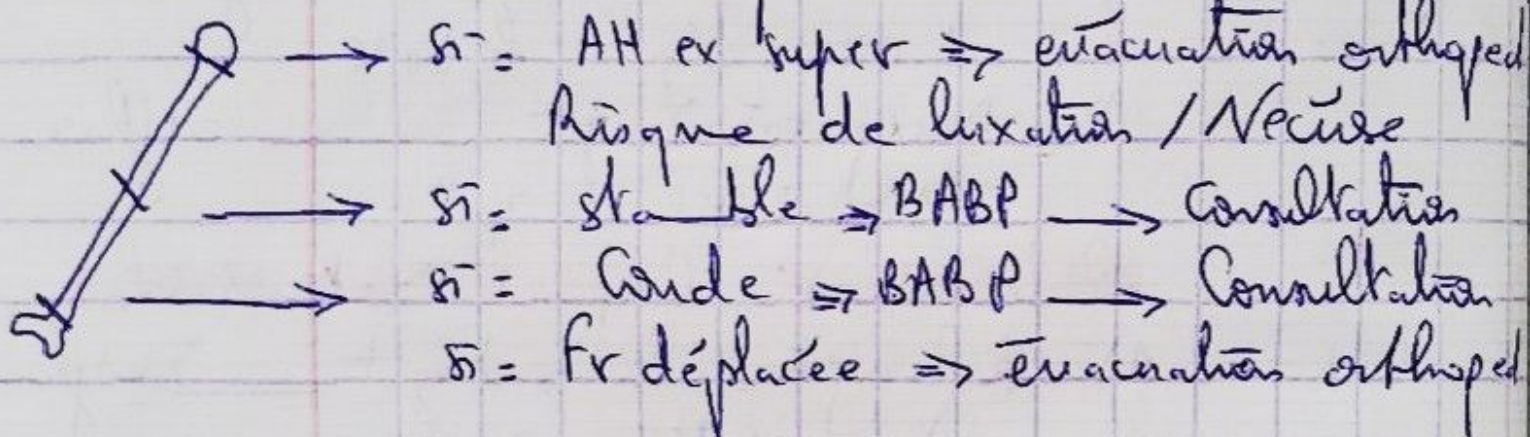
* œdème aux extrémités sup

↳ Rx de l'épaule Dou G (F+P)

* Diaphyse → Rx de Totalité H (F+P)

* ex inf → Rx du coude D/G (F+P)

• Alerte plâtre BABP



Fractures aux Urgences : Avis orthopéd

* Fr ouvertes risque de surinfection

* Lésion neuro (sensibilité / Motricité)

* Alerte Vx (pâleur / puls) Nécrose

Articulation bloquée → Consultation

Déplacement → avis en urgence

Fr inf coude → Rx Avant - Bras

Si enfant → Avis CCI

Arrêt de travail 15 j

70

* Fracture de clavicule :

99%

- ⇒ Soulager la douleur : on flacon parafalgan
- Rx de la clavicule face au TLT de face
- les 2 clavicules pour comparer, CPC, pneumothorax
- ⇒ Risque de HHT Vx ⇒ Avis orthoped.
- Luxation d'épaulle ⇒ " "
- Rx de contrôle de 8j 15j 21j 45j
- ⇒ Bandage en 8.

* Fracture de l'Avant-Bras :

• chez l'enfant :

- ⇒ Soulager la douleur : Voltaline en 1/4 ou
- ⇒ Applique plâtre BABP parafalgan.
- ⇒ Réduire au CI (Réduction)

• chez l'Adulte :

⇒ Trt chirurgical

⇒ Soulager la douleur puis consultation

post. → orthoped.

si fr infer et antérieur → Vx

fr déplacée ⇒ orthoped en urgence!

fr stable en trait ⇒ BABP

⇒ Consultation orthoped!

(71)

* Fracture de la main :

⇒ Rx de main (F+P)

1 - Scaphoïde : tiré ponce ⇒ Douleur
Bulger Douleur o 1 Amp Voltarene 100
ou parafan en IV

• Si = fr stable ou normal ⇒ Arelle
Antibactérien palmaire + gant plâtre
→ Consultation orthopéd!

• Fr déplacée ⇒ Avis orthopéd urgent

2) - 1^{er} Métacarpien :

⇒ Antalgique + Rx Si = fr Arelle + gant

→ Avis orthopéd usq → déplacé

3) - 2-3^e → métacarpien même CAT
fixe (2+3) ou (3+4) (4+5)
Consultation orthopéd!

4) - phalanges : vers l'avant int.

ex = 4^e + 3^e

↓

fr

* Sd grippal : fièvre 38°-40°c, Maux de tête, Toux sèche, fatigue, courbatures, frissons, Dlr corps 1 mois

1/ - Humex _____ 01 bte

03 cp le jour le gél le soir
ou Dolibume _____ 01 bte

01 cp 3x/j

2/ - Effera lgm 500mg cp _____ 01 bte
01 cp 3x/j

3/ - Vit-C cp 500mg _____ 01 bte
01 cp 2x/j matin et midi

ou Sargenor vit-C _____ 01 bte
01 Amp 2x/j matin et midi

⇒ éviter l'exposition prolongée sans soleil, repas
légers, boissons +++

⇒ Vaccin de sujet à risque

0,5 ml en sc en automne en dehors de H
infectieuse ou congestion ORL.

1/ - Paracétamol cp 500mg / sucr / sup _____ 01 bte
01 cp 3x/j 30 mg / kg / j

2/ - UPSA Vit-C - cp 01 cp 3x/j

3/ - Rhinathiel sup 01 càs 3x/j

4/ - Soufrane sol 02 pulv / Narine 3x/j

ou Souframycine sol 01 pulv / Narine 3x/j

(73)

* Rhume :

⇒ pas de fièvre, mal de gorge, toux modérée
Nz blanc hê ou coule dure : 10j

* Grippe :

- Biovex sach 01 sachet 2x 1j
- Dolipran cp 500 01 cp 3x 1j
- Vit C + Zinc cp 01 cp 1j
- Ebasca cp 10mg 01 cp 1j

(F4)

* Bronchite :

- pas de fièvre - Bronchite comme l'asthme sirotants enfant < 2 ans
 pas de fièvre, Rx Normal @ 3 épisodes
- il y a de fièvre - Bronchite Respirants } 2 ans Rx Normal, Toux grasse
- fièvre grasse - pneumonie fièvre ↑ dyspnée Rx Amox Crépitrants

Ordonnance :

1) - Clamoxyl 1g inj _____ QSP = 10j
 01 inj / j le matin

2) - Clamoxyl 1g gel _____ QSP = 10j
 01 gel / j le soir.

Si : allergie

1) - Zithromax 250mg cp _____ 01 ste
 2 cp / j en une seule prise en dehors repas
 puis 1 cp / j pdt 04j

3) - Diclofenac sup 100mg _____ 01 ste
 01 sup / j le soir pdt 6-7j

4) - Efferalgan 1000mg cp _____ 01 ste
 01 cp 4-5x / j

Si : Toux sèche → Euphon sup _____ 01 fl
 1 cà s 6x / j pdt 5-6j

Si : Toux sèche + éternuement et signes d'allergie
 Demoral sup _____ 01 fl
 01 cà s 4x / j (75)

Expectorations à respecter (pas Antitussifs)
 Si = encaisse 1 18p =
 Fluimucil 200mg sachet 01 4te
 01 sachet 3x 1j

• Bronchite aigue asthmatoïdienne :

- 1) - Augmentin cp 500mg / swt 125 / 250mg - 10j OSP
 01 cp 2x 1j 50mg / kg 1j
- 2) - Fluimucil sachet 01 4te
 01 sachet 3x 1j
- 3) - Becotide spray 01 4te
 01 pulv 2x 1j
- 4) - Théophylline 24cp 01 4te
 01 cp 2x 1j

* Aphtes :

- Aph 1us cp 01 4te
 01 cp 3-4 cp 1j
- ou Dakarim gel 01 tube
 02 App 3x 1j
- + Bicarbonate de soude sol bain de
 bouche 3x 1j
- * Poussee dentaire : Deb dent

* Appendicite :

⇒ Douleur FID ou épigastrique vers FID, Nausée / Vomissements $37,5-38,5^{\circ}\text{C}$

examen : Douleur paroxysm. à la palpation de FID
Défense parietale, douleur au TR.

⇒ FNS : Hypertendus, sténocorde, iléus paralytique

Trt : Urgence chirurgicale

(H) + R = Antibiotation + ATB paroxysm. = occlusion

* Fissure anale :

1/ - Nitral plus _____ 024/3

01 app 3x/j

2/ - Diclufenac cp 75mg _____ 014/2

01 cp/j en milieu de repas

3/ - Zompéprazole gel 20mg _____ 014/2

01 gel/j

4/ - Forlax sac 1 sac _____ 014/2

01 sac 1/j

* Dysurie :

1/ - Fluvermal sup 100mg _____ 01 flc

01 c/c en seul prise 1 2 3 renouvelé

2/ - Vanileb sup _____ en 15 16 17

01 c/c 3x/j

+ Hygiène des mains

(77)

8: Vomisse

* Intoxication alimentaire : on Hydrogne Adulte :

1) - Bactrim 200/400 _____ QSP: 07j
01 cp 3x1j

2) - Flagyl 500mg _____ QSP: 07j
01 cp 3x1j

3) - Dysentyl 200mg _____ 01 flc
02 cp 3x1j

4) - clomperane 10mg _____ 01 flc
01 cp 3 à 4x1j

5) - sparflox 1600 _____ 01 flc
01 cp 3x1j

⇒ Cocktail en perfusion = Eph
500mg flagyl + 01 Amp sparflox
+ 01 Amp prümperan si Vomité

Order cell :

1) - Flagyl cp 500mg _____ QSP: 07j
01 cp 3x1j

si Vomité + 2) - Vomité d 5mg _____ 01 flacon
01 cà c 3x1j - 1h avant le repas

si Diarrhée 3) - Imodium cp _____ QSP: 102j
01 cp 3x1j



* Traumatisme thoracique =
 • Fracture costale 1^{er} & 2^e côtes

1) - Elastoplast _____ N° = 05

2) - Doliprane cp 1g _____ 01 sup 1j
 01 cp 3x1j

3) - Voltarene cp 75mg _____ 01 sup 1j
 01 cp 3x1j

4) - Zimac gel 20mg _____ 1/1j
 01 gel 2x1j

• Affection musculo-squelettique =

1) - Kifenex patch _____ 01 sup 1j
 01 patch 2x1j

2) - Doliprane cp 1g _____ 01 sup 1j
 01 cp 3x1j

3) - 3 côtes ⇒ Admission surveillance

* Plaie par arme blanche =

1) - Oxacilline cp 500mg _____ 01 cp 3x1j

2) - Niflural sup 750mg _____ 01 sup 1j

3) - Zimac gel 20mg _____ 01 gel 2x1j

4) - Codolipran cp _____ 01 cp 3x1j

* Chute haut =

Coste droit = Rx Thorax

" gauche = échographie

* Constipație :

1. - Duphalac sup 01 căc 02x/j.
- Glycérine suppo 1-2 suppo/j.
- Laxax (Lactulose) sup 01 căm 01x/j.
- Forlax sachet 040mg (E) 01 sachet
- 10mg (A) 03x/j.

(Debrüdat)

- Trimebutine cp 01cp 02x/j.
- Duphalac sachet 01 sachet 3x/j.
- Bedelix sachet 01 sachet 3x/j.
- Debrüdat cp 100mg 01cp 3x/j.
- Huile de parafine 01 căm 2x/j.
- Sparfon lyoc 01 lyoc 3x/j.
- 01 vâlcuș d'EAU MATIN
- 01 căc huile d'olive se sear

* Vomissements :

- Domperidone cp 01cp 2-3/j 15 min avant R
- Prémperan cp 5mg
- CI si = epilepsie / parkinson
- Vogalène gel 15mg 01gel 1-2x/j

(20)

* Abscès périanal :

1) - flugyl cp 500mg _____ φ SP = 10g
 olcp 3x 1g

2) - Oxacilline cp 500mg _____ φ SP = 10g
 olcp 2x 1g

3) - Voltaren cp 75mg _____ ol4te
 olcp 1g

4) - Zénac gel 50mg _____ ol4te
 olgel 1g

5) - Permanganate de K⁺ _____ ol4te
 olcp diluée ds 5l d'eau tiède puis choyer et lèche

* Abscès — anal :

* Abscès anal :

Non collectée :

Ceface K cp 1g _____ φ SP = 10g
 olcp 3x 1g

Dolipran 1g cp _____ ol4te
 olcp 3x 1g

Collec — K⁺ Drainage

* Plaque infectée :

φ SP = 10g

- ceface K cp 1g 1cp 3x 1g
- profim d cp 100mg 1cp 2x 1g

81

Amox ou
 Dolipran =

* RGO :

- Gaviscan Sachet / suşu _____ 01 ste
01 sachet 3x1j
- Mulex suşu _____ 01 ste
01 cam 3x1j
- Azenkac cp 300mg _____ 01 cp 1j } QSP :
- Omeprazole (IPP) 10/20mg - 1 gel 1j } 01 mes

* Ulcere gastro - duodenale :

- Lomeprazole gel 20mg _____ QSP : 01 mic
01 gel 2x1j pdt 7j avant
01 gel 1j pdt 21j & 1 rep
- Amoxicilline gel 500mg _____ QSP : 10j
02 gel 2x1j hors les repas -

* Pancréatite :

- Cefaclor 1g 4x1j - spazfon 01mg 3x1j
- Flacyl 500mg 3x1j - Azenkac 01mg 1j
- pefalgan 1g 4x1j - clafuran 01g 3x1j

* Occlusion :

ASP / TDM

* Cholecystite aiguë :

⇒ Admission + Trt ATB

- Ceface 1g 3x1j } en IVL
- Flagyl 500mg 3x1j }

+ Antalgique = paraf 1g 3x1j

+ Antispasmodique = Spasfon 2Amp 3x1j

+ Réhydratation = 1500 cc SSI
1500 cc SGI

* Angiocholite :

⇒ Admission + Trt identique au cholecystite

* Appendicite :

⇒ Admission + Trt identique sauf ATB

* Péritonite :

⇒ Admission + Trt standard + chir en urgence

* Aérocolie :

1 - Métréoxone gel _____ o15te

o1ge 3x1j

2 - Daburidat _____ o15te

o1ca 3x1j

* Leishmaniose Cutanée.

- lésion multiple : Glucantime IM profonde.
- lésion unique sur uv face : Glucantime IM
- // unique aux MI : infiltrations cutanées
0.2 cc 2x/sem pdr 04 semaines

* Glucantime en IM profonde :

• enfant : Dose en cc = $\frac{4 \times \text{poids} \times 20}{100}$

le 1^{er} j = 1/4 dose 425

le 2^{ème} j = 1/2 dose

le 3^{ème} j = 3/4 dose

le 4^{ème} j = Dose complète pdr 10j

• Adulte :

1^{er} j = 1cc / IM

2^{ème} j = 2cc / IM

3^{ème} j = 3cc / IM

4^{ème} j = 4cc / IM pdr 10j

CI = insuff rénals, insuff hépat, Cardiopathie
NRS < 2ans.

il faut = ECG + TLT

bilan = FNS / TP / bilan rénal
et hépatique.

* Bouchon du Cerumen

- 1) - H_2O_2 solu = eau oxygénée
nettoyage 3x1j
- 2) - Outilyse 2,5g / 100ml solut } 05j
2x1j

après 5ème j $\Rightarrow$ extraction du Bouchon
de un OHL.

ou Cerulysse gtt ———— 01 flacon.
02 gtt 3x1j pdr 00j.

* Otite:

• otite externe: Douleur lors de traction du pavillon
ou l'appui sur tragus

• otite moyenne: y a des versiges, tympan bouché

1) - Otocine dextre 01 dose 2x1j 05le 8j

2) - Otiprane cp 1g 01cp 2x1j

1) - Otofa gtt 01 gtt 2x1j 05p 05j

Otocine chez enfant > 2 ans.

faut

* Herpes circiné:

Varo crème 01 App 2x1j pdr 20j

Betacyl pmd 01 App 1j pdr 15j

Kétocanazole 01 App 2x1j

(85)

* Embolie Pulmonaire :

- Clinique : Syncope - Lipothymie
Tachycardie > 100 , douleur angineuse
par le paradoxe, cyanose.
 $\Rightarrow$ état de choc : marbrures, collapsus
 $\Rightarrow$ Trouble de Repolarisation : T, V₁-V₃, BBL
 $\Rightarrow$ Hypoxie sévère $PaO_2 < 60\%$, acidose

* CAT :

* O₂ fort débit

* Remplissage Vasopresseurs : Dobutrex,
NorAdrénaline

* HNF 500 UI/kg/j en PSE avec TCA à
H₄ objectif : 2-3.

* Thrombolyse : si EP + état de choc

* Re-lais AVK + anti-X à J₄ avec
surveillance : TCA, fibrinogène, p_a
si échec : embolectomie chirurgicale

* Clinique : Probabilité faible ou moyenne
Dosage D-D si (+) $\Rightarrow$ AngioScanner.
si doute : éliminer TVP + Scintigraphie

Probabilité forte $\Rightarrow$ Angioscanner si (-) $\Rightarrow$
échodoppler

$\Rightarrow$ Position demi-assise, O_2 & SpO_2 $> 95\%$
WP (bilan Hémobase avant anticoagulation)
HBPM en s/c immob 175 UI/Kg en 1 inj / j
ou Lovenox 100 UI/Kg 2x/j

OAP $\Rightarrow$ râles crépitants, orthopnée, dyspnée
Radio: râle de papillon
pas douleur, Notion d'HVA ou Cardiopath

EP $\Rightarrow$ TVP / immobilité / grossesse / Né
Rx: Na... D-Dimères positifs (+)
douleur banthracique, hémoptysie

IDM $\Rightarrow$ Douleur constrictrice, ECG et troponine
(+)